



ÎNȚELEGEREA ANGIOEDEMULUI EREDITAR (AEE)

CUPRINS

Ghid despre AEE	1
Tipurile de AEE	3
Simptomele AEE.....	4
Factorii declanșatori ale atacurilor	6
Diagnosticarea AEE	9
Opțiuni de tratament.....	10
AEE și copii	19
Femei și sarcină.....	20
Călătorii.....	21
Despre HAEi.....	22
Resursele HAEi.....	22
– Aplicația HAE TrackR	25
– Carduri de urgență.....	26
– Aplicația HAE Companion	26
– Programul de Acces Global.....	26
– Site web și rețele sociale	27
– Ziua globală de conștientizare hae day :-)	28
– Revista Global Perspectives	29
– Conferințe și ateliere AEE	29
– Comunitatea Tinerilor HAEi	30



HAEi thanks the US HAEA for
their significant contribution
to the content of this guide.

GHID DESPRE AEE

Angioedemul Ereditar (AEE) este o afecțiune genetică foarte rară și potențial fatală, care apare la aproximativ 1 din 10.000 până la 1 din 50.000 de persoane.

AEE provoacă simptome de angioedem (umflare) în diverse părți ale corpului, inclusiv: mâini, picioare, față și gât/căi respiratorii. Persoanele cu AEE suferă adesea de dureri abdominale insuportabile, greață și vărsături cauzate de umflarea peretelui intestinal. Umflarea căilor respiratorii sau a gâtului este deosebit de periculoasă, deoarece poate cauza moartea prin sufocare.

Majoritatea persoanelor cu AEE au un defect în gena care controlează o proteină importantă numită C1-inhibitor, care se găsește în plasmă – partea lichidă a sângelui. Din cauza acestui defect genetic, C1-inhibitorul la persoanele cu AEE nu își îndeplinește funcția de a controla interacțiunile biologice complexe din plasmă. Necontrolate, aceste interacțiuni produc o substanță numită bradikinină, care provoacă umflarea prin permiterea fluidelor plasmatice să pătrundă în țesuturile moi ale diverselor părți ale corpului. După cum se descrie pe pagina următoare, AEE cu deficit de C1-inhibitor este clasificat în Tipul I și Tipul II.

Există și persoane care prezintă simptome similare cu Tipul I și II, dar analizele de sânge arată niveluri și funcție normale ale C1-inhibitorului.



TIPURILE DE HAE

AEE TIP I - 85% din persoanele cu AEE

Aceasta este cea mai frecventă formă a afecțiunii și se caracterizează prin niveluri cantitative scăzute de C1-inhibitor.

AEE TIP II - 15% din persoanele cu AEE

Testele de laborator arată niveluri normale sau crescute de C1-inhibitor, dar proteina nu funcționează corect.

Absența unui istoric familial nu exclude diagnosticul de AEE cauzat de deficiența de C1-inhibitor. Până la 25% din cazurile de HAE rezultă dintr-o mutație spontană a genei C1-inhibitorului la concepție. Copiii au 50% șanse să moștenească HAE dacă unul dintre părinți are această afecțiune.

AEE cu C1-inhibitor normal

Simptomele sunt consistente cu AEE tip I și II, dar rezultatele de laborator arată niveluri și funcție normale ale C1-inhibitorului.

Studiile recente au confirmat că AEE cu C1-Inhibitor normal include un număr de mutații genetice care sunt conectate cu umflarea. Așteptarea este ca mai multe astfel de mutații să fie identificate în viitor.

SIMPTOMELE AEE

Atacuri cu umflare și durere

Persoanele cu AEE experimentează atacuri de umflare care afectează diverse părți ale corpului. Atacurile de umflare apar cel mai frecvent la nivelul pielii (de exemplu, mâini, picioare, față), abdomenului (tractul gastrointestinal) și gâtului/căilor respiratorii (laringe).

Fără tratament, atacurile pot dura între două și cinci zile. Frecvența și severitatea atacurilor pot varia dramatic între persoanele cu AEE. Ele pot varia și la aceeași persoană în diferite etape ale vieții.

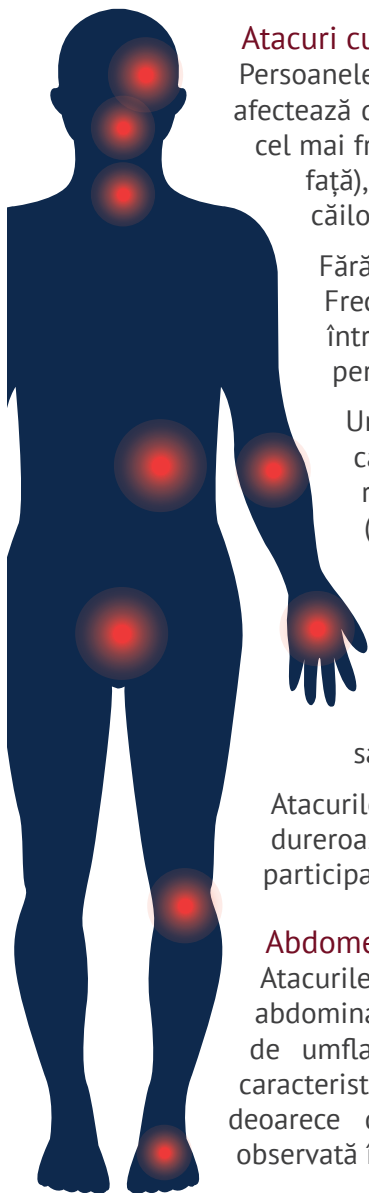
Umflarea legată de AEE NU este aceeași cu umflarea cauzată de alergii și nu poate fi tratată ca o reacție alergică. Antihistaminicele, corticosteroizii (prednison) și epinefrina sunt inefficiente în ameliorarea simptomelor de angioedem AEE.

Aproximativ 25% dintre persoanele cu HAE experimentează o erupție cutanată roșie, neuniformă, fără mâncărime (poate apărea și sub formă de cercuri roșii), care apare adesea înainte sau în timpul unui atac de AEE.

Atacurile de umflare sunt desfigurante și pot fi extrem de dureroase și debilitante, până la punctul de a împiedica participarea la activitățile zilnice normale.

Abdomen

Atacurile gastrointestinale implică de obicei dureri abdominale insuportabile, greață, vărsături și diaree cauzate de umflarea peretelui intestinal. Aceste simptome sunt caracteristici distinctive ale AEE cu deficit de C1-inhibitor, deoarece durerea abdominală severă recurentă este rar observată în angioedemul alergic (histaminergic).



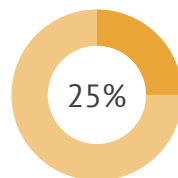
Gât/căi respiratorii

Episoadele de umflare a gâtului/căilor respiratorii sunt cele mai periculoase simptome AEE, deoarece căile respiratorii se pot închide și pot cauza decesul prin sufocare.

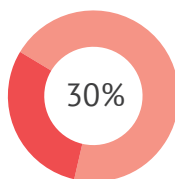
Studiile indică faptul că rata mortalității pentru persoanele cu AEE netratate cu angioedem al căilor respiratorii poate fi de aproximativ 30%.

Vă rugăm să rețineți că 50% dintre persoanele cu AEE experimentează cel puțin o umflare a gâtului/căilor respiratorii în cursul vieții lor.

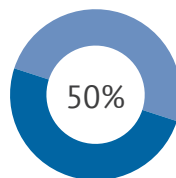
Este important de recunoscut că umflarea gâtului este o urgență care necesită întotdeauna asistență medicală imediată la primul semn de simptome, chiar dacă alte medicamente AEE sunt administrate acasă.



Aproximativ 25% dintre persoanele cu HAE experimentează o erupție cutanată roșie, neuniformă, fără mâncărime (poate apărea și sub formă de cercuri roșii), care apare adesea înainte sau în timpul unui atac de AEE.



Decesul cauzat de umflarea gâtului/căilor respiratorii la persoanele netratate cu HAE poate fi de aproximativ 30%.

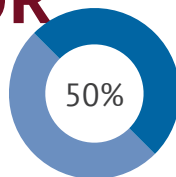


50% dintre persoanele cu HAE experimentează cel puțin o umflare a gâtului/căilor respiratorii în cursul vieții lor.

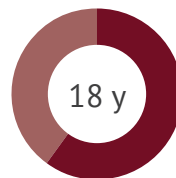
FACTORII DECLANȘATORI ALE ATACURILOR

Studiile sugerează că 50% dintre persoanele cu AEE raportează primele simptome până la vârsta de 10 ani, iar majoritatea oamenilor au experimentat simptome/primul atac înaintea vârstei de 18 ani.

Chiar dacă sunt excepții, simptomele AEE sunt de regulă ușoare la copiii mici, dar episoade au fost raportate chiar și la copii de un an. Frecvența atacurilor poate să crească la pubertate și adolescență.



50% dintre persoanele cu AEE raportează primele simptome până la vârsta de 10 ani.



Majoritatea oamenilor au experimentat simptome/primul atac înainte de vârsta de 18 ani.

Factorii declanșatori comuni ai AEE

Factorii declanșatori comuni ai AEE sunt:

- Anxietate
- Stres
- Traumatisme minore
- Intervenții chirurgicale
- Boli precum răceala/gripa/alte infecții virale

Persoanele cu AEE au mai raportat și alți factori declanșatori, cum ar fi:

- Expunerea la frig
- Activități care provoacă traumatisme mecanice, cum ar fi grădinaritul

Hormoni

La femei, menstruația și sarcina pot afecta simptomele AEE. Unele femei cu AEE raportează o creștere a numărului de atacuri în timpul perioadelor menstruale. Studiile științifice relevă că există variații considerabile în frecvența atacurilor experimentate de femeile cu AEE însărcinate.

Utilizarea medicamentelor derivate din estrogen, cum ar fi contraceptivele orale și terapia de substituție hormonală este, de asemenea, asociată cu o creștere a frecvenței și severității atacurilor de AEE.

Persoanele cu AEE ar trebui să consulte medicul curant AEE cu privire la opțiuni alternative de contracepție fără estrogen.

Inhibitorii ECA

Utilizați frecvent pentru tratarea hipertensiunii arteriale, inhibitorii ECA sunt cunoscuți pentru creșterea frecvenței și severității atacurilor de AEE și, prin urmare, ar trebui evitați.

Proceduri dentare

Traumatismele bucale cauzate de procedurile dentare pot declanșa umflarea orală și pot crește riscul de umflare a gâtului/ căilor respiratorii. Consultați medicul curant AEE înainte de a efectua proceduri dentare.



DIAGNOSTICAREA AEE

Cum se diagnostichează AEE

Majoritatea cazurilor de angioedem sau umflare NU reprezintă AEE sau deficit de C1-inhibitor.

Analiza de laborator a probelor de sânge sau a probelor genetice este necesară pentru a stabili diagnosticul de AEE. Există trei analize specifice de sânge utilizate pentru confirmarea angioedemului ereditar de Tip I sau II:

- C1-inhibitor cantitativ (antigenic)
- C1-inhibitor funcțional
- C4

AEE cu C1-inhibitor normal

La persoanele cu HAE cu C1-inhibitor normal, nivelurile și funcția C1-inhibitorului sunt normale. Cercetătorii au descoperit că, în unele cazuri, AEE cu C1-inhibitor normal este asociat cu mutații ale genelor factorului XII (F12), plasminogenului (PLG), angiopoietinei (ANGPT1), kininogenului (KNG1) sau myoferilinei (MYOF). Cu toate acestea, în multe cazuri, cauza genetică a AEE cu C1-inhibitor normal este necunoscută. Unele laboratoare comerciale pot testa mutațiile Factorului XII, însă nu există teste de laborator de rutină pentru a confirma un diagnostic de AEE cu C1-inhibitor normal.

DESPRE CLASELE ȘI DENUMIRILE MEDICAMENTELOR

Medicamentele cu anumite similitudini pot fi grupate în clase de medicamente. Similitudinile pot fi datorate structurii chimice a medicamentului, modului de acțiune al acestora sau faptului că sunt utilizate pentru tratarea aceleiași boli.

Fiecare medicament are un nume generic aprobat. Acesta este numele substanței active din acel medicament particular. Deoarece mai multe companii pot produce același medicament generic, fiecare companie va da produsului său un nume de marcă sau comercial.

Un exemplu în acest sens este analgezicul ibuprofen.

- Clasa de medicamente din care face parte ibuprofenul este cea a medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene.
- Denumirea generică este ibuprofen, și există mai multe companii care îl produc cu denumiri comerciale precum Advil®, Neurofen®, Motrin®, Ibumetin®, Dolgit®.

Vom face referire la clasele de medicamente și denumirile generice atunci când discutăm medicamente specifice pentru AEE.

OPȚIUNI DE TRATAMENT

Există tratamente eficiente care ajută la reducerea frecvenței și severității umflăturilor și ameliorează simptomele. Din păcate, similar cu multe alte boli rare, nu există un tratament curativ pentru AEE.

Obiectivele tratamentului AEE sunt de a obține controlul complet al bolii și de a normaliza viața pacienților. Cercetările continuă pentru a dezvolta medicamente din ce în ce mai eficiente pentru AEE. Cu medicamentele moderne eficiente disponibile astăzi pentru AEE, unele persoane raportează că pot trăi practic fără umflături.

Strategiile actuale de tratament AEE se concentrează pe medicamente pentru:

- Ameliorarea rapidă în timpul atacurilor (tratament la cerere sau acut)
- Prevenirea simptomelor la persoanele cu AEE care au o frecvență ridicată a atacurilor (profilaxie pe termen lung)
- Prevenirea simptomelor la persoanele cu AEE care se supun procedurilor dentare sau chirurgicale, care pot declanșa un atac (profilaxie pre procedurală sau pe termen scurt).

Deși simptomele pot fi adesea confundate cu o reacție alergică, atacurile AEE nu răspund la tratamentele comune pentru alergii, inclusiv antihistaminice, corticosteroizi sau epinefrină.

Toate persoanele cu AEE ar trebui să colaboreze cu medicul lor pentru a elabora un plan individualizat de gestionare a AEE.

TRATAMENT LA CERERE SAU ACUT

Tratamentul la cerere sau acut este utilizat pentru a opri progresia umflăturii și pentru a ameliora simptomele. Utilizarea rapidă a tratamentului la cerere sau acut este deosebit de importantă atunci când umflarea se află la nivelul gâtului sau al căilor respiratorii. Dacă atacul la nivelul gâtului este lăsat netratat, poate duce la deces prin sufocare (asfixiere).

Terapiile AEE (Tip I și II) pentru tratamentul la cerere sau acut variază de la țară la țară, deoarece tratamentele specifice nu sunt autorizate în toate țările.

Tipurile de medicamente specifice AEE disponibile și recomandate pentru tratamentul la cerere sau acut includ:

- Concentrat de C1-inhibitor intravenos
 - Produse fabricate din plasmă sanguină (concentrat pdC1-inhibitor)
 - Produse care nu sunt fabricate din plasmă sanguină (concentrat recombinant sau rhC1-inhibitor)
- Inhibitor de kalikreină plasmatică
 - Ecallantidă
- Antagonist al receptorilor de bradikinină
 - Icatibant

În țările în care tratamentele specifice AEE la cerere sau acut nu sunt disponibile, medicii sunt limitați la medicamente nespecifice AEE sau chiar doar la analgezice.

Ghidul Internațional WAO/EAACI pentru Managementul Angioedemului Ereditar face următoarele recomandări pentru tratamentul acut sau la cerere al AEE:

- Tratamentul precoce cu concentrat de C1-inhibitor intravenos, ecallantidă sau icatibant oferă un răspuns mai bun decât tratamentul tardiv; ducând adesea la un timp mai scurt până la ameliorarea completă a simptomelor și la o durată mai scurtă a umflăturii generale.
- Atacurile de AEE ar trebui tratate cât mai devreme posibil. Tratamentul precoce poate fi realizat prin autoadministrare. Toate concentratele de C1-inhibitor și icatibantul sunt autorizate pentru autoadministrare, deși utilizările aprobate ale produselor variază în întreaga lume.
- Dacă concentratele de C1-inhibitor, ecallantida sau icatibantul nu sunt disponibile, atunci se utilizează plasma tratată cu solvent-detergent (SDP)
- Dacă SDP nu este disponibil, atunci plasma proaspătă congelată (FFP) trebuie utilizată pentru tratarea atacurilor, acolo unde există o aprovizionare sigură.

Experții care au elaborat ghidul recomandă evitarea utilizării antifibrinoliticelelor (de ex., acid tranexamic) sau androgenilor (de ex., danazol) ca tratamente la cerere pentru atacurile de AEE. Studiile arată că nu există efecte sau efectele sunt foarte mici atunci când sunt utilizate în acest mod.

PROFILAXIA PE TERMEN LUNG

Profilaxia pe termen lung (PTL) constă în utilizarea regulată a medicamentelor de către o persoană cu AEE pentru a preveni apariția episoadelor de umflare. PTL reduce numărul atacurilor de umflare pe care o persoană cu AEE le experimentează și în cazul utilizării unor medicamente moderne de profilaxie unele persoanele cu AEE nu mai au atacuri deloc.

Terapiile AEE (Tip I și II) pentru PTL variază de la țară la țară, deoarece tratamentele specifice nu sunt autorizate în toate țările.

Această strategie de tratament ar trebui adaptată individual și luată în considerare pentru toate persoanele cu AEE, ținând cont de frecvența și severitatea atacurilor, calitatea vieții individuale, disponibilitatea resurselor de îngrijire a sănătății și eșecul de a obține un control adecvat cu tratamentele la cerere sau acut.



Deoarece episoadele de umflare pot apărea în continuare chiar dacă se utilizează PTL, toate persoanele cu AEE care utilizează PTL ar trebui să aibă, de asemenea, medicamente la cerere disponibile.

În ultimii ani, medicamente suplimentare pentru PTL au fost aprobate de autoritățile de reglementare a medicamentelor. Tipurile de medicamente specifice AEE disponibile și recomandate pentru PTL includ:

- Concentrat de C1-inhibitor
 - produse fabricate din plasmă sanguină (concentrat pdC1-inhibitor)
- Inhibitor de kalikreină plasmatică
 - lanadelumab
 - berotralstat

Acolo unde aceste medicamente nu sunt disponibile, androgenii atenuați pot fi utilizați pentru PTL. S-a demonstrat că reduc numărul de atacuri de umflare. Cu toate acestea, ei au multe efecte secundare, contraindicații și interacțiuni medicamentoase.

Antifibrinoliticele, precum acidul tranexamic, pot fi utilizate și pentru PTL atunci când androgenii atenuați sunt contraindicați. Antifibrinoliticele nu sunt recomandate în mod oficial, însă experții ghidului au remarcat că unele persoane cu AEE le pot găsi utile. Efectele lor secundare sunt, de obicei, minore.

PROFILAXIA PE TERMEN SCURT

Profilaxia pe termen scurt se efectuează de obicei înainte de procedurile chirurgicale sau tratamentul dentar. Procedurile dentare sau intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea amigdalelor sunt factori declanșatori potențial critici, deoarece pot provoca umflarea gâtului/căilor respiratorii (laringe).

Acolo unde este disponibil, utilizarea concentratului de C1-inhibitor derivat din plasmă (pd) intravenos este tratamentul ales pentru profilaxia pe termen scurt. Acesta trebuie administrat cât mai aproape de începerea procedurii.

Concentrat recombinat de C1-inhibitor poate fi utilizat de asemenea dacă pdC1-inhibitor nu este disponibil. Când niciuna din aceste variante nu este disponibilă:

- Plasma proaspătă congelată (FFP) poate fi utilizată
- Androgenii atenuați pot fi, de asemenea, luați în considerare ca alternativă. Pentru profilaxia programată pre-procedurală, androgenii sunt utilizați timp de 5 zile înainte și 2-3 zile după eveniment.

Există întotdeauna posibilitatea ca un atac să apară, deci tratamentul la cerere trebuie să fie disponibil în timpul procedurii.

TRATAMENTUL AEE LA COPII

Similar cu adulții, toți pacienții pediatrici cu AEE ar trebui să aibă un plan de gestionare a bolii, inclusiv un plan de acțiune terapeutică, împreună cu medicul lor.

Terapiile AEE (Tip I și II) pentru copii variază de la țară la țară, deoarece tratamentele specifice nu sunt autorizate în toate țările.

Terapiile disponibile și recomandate pentru tratarea AEE la copii și adolescenți includ:

- Concentrat de C1-inhibitor
 - Produse fabricate din plasmă sanguină (concentrat pdC1-inhibitor)
 - Produse care nu sunt fabricate din plasmă sanguină (concentrat recombinant sau rhC1-inhibitor)
- Antagonist al receptorilor de bradikinină
 - Icatibant

Acolo unde aceste medicamente nu sunt disponibile, plasma tratată cu solvent-detergent (SDP) este preferată plasmei proaspete congelate (FFP), dar ambele pot fi luate în considerare.

Tipurile de medicamente specifice AEE disponibile și recomandate pentru profilaxia pe termen lung (PTL) la copii și adolescenți reflectă, în general, pe cele disponibile pentru adulți. Acolo unde concentratul de C1-inhibitor nu este disponibil, antifibrinoliticele, precum acidul tranexamic, pot fi utilizate pentru PTL. Datorită profilului lor de siguranță mai bun, PTL cu antifibrinolitice este preferată în locul androgenilor la copii. Cu toate acestea, există o lipsă de date care să susțină utilizarea acestora.

Similar cu adulții, acolo unde concentratul de C1-inhibitor este disponibil, acesta este preferat pentru profilaxia pe termen scurt. Un tratament scurt cu androgeni atenuați poate fi utilizat ca alternativă atunci când concentratul de C1-inhibitor nu este disponibil. Există întotdeauna posibilitatea apariției unui atac, prin urmare tratamentul la cerere trebuie să fie disponibil pe parcursul procedurii.



AEE ȘI COPIII

Defectul genetic care cauzează AEE este ereditar. Copiii unui părinte cu AEE au 50% șanse să moștenească afecțiunea.

Testarea este esențială

Odată ce o persoană este diagnosticată, experții recomandă ca toți membrii familiei apropiate (părinți, frați și copii) să fie testați pentru AEE. Testarea pentru AEE este posibilă în primul an de viață, cu toate acestea, unii medici recomandă să așteptați până când copilul are cel puțin un (1) an înainte de testare. Aceasta se datorează nivelurilor foarte variabile de C1 antigenic și C4 în primul an de viață. Testarea precoce permite părinților sau tutorilor legali să colaboreze în avans cu medicul copilului pentru a crea un plan de tratament individualizat.

Debutul simptomelor AEE la copii variază

Vârsta de debut a AEE variază considerabil, cu toate acestea, studiile sugerează că 50% dintre persoanele cu AEE raportează primele simptome până la vârsta de 10 ani și majoritatea oamenilor au experimentat simptome/primul atac înainte de vârsta de 18 ani. De asemenea, pare să existe o frecvență crescută a atacurilor în timpul pubertății sau adolescenței.

FEMEI ȘI SARCINA

Dacă doriți să rămâneți însărcinată sau sunteți însărcinată, medicul dumneavoastră vă va urmări îndeaproape pentru a discuta managementul adecvat al AEE.

Tratamentul AEE

În timpul sarcinii și alăptării, tratamentul cu androgeni anabolizanți (sau steroizi) sau acid tranexamic nu este recomandat. Medicul curant AEE vă poate ajuta să elaborați un plan de tratament specific nevoilor dumneavoastră individuale înainte, în timpul și după naștere și în timp ce alăptați.

Atacuri de AEE

Femeile cu AEE raportează că fiecare sarcină poate fi diferită. În unele cazuri, femeile pot experimenta atacuri de AEE mai frecvente și/sau mai severe, în timp ce în alte cazuri, femeile pot constata că au puține sau deloc atacuri de AEE în timpul sarcinii.

Naștere

Majoritatea femeilor cu AEE au parte de o naștere sănătoasă a copilului lor, la fel ca cele din populația generală. Atacurile de AEE sunt rare în momentul nașterii. Există unele indicii privind o creștere a frecvenței și severității atacurilor în perioada post-partum.

Bebelușul meu

Așa cum s-a menționat anterior, AEE este o afecțiune ereditară și fiecare copil născut unui părinte cu AEE are 50% șanse să moștenească afecțiunea. Testarea pentru AEE este posibilă în primul an de viață, cu toate acestea, unii medici recomandă să așteptați până când copilul are cel puțin un (1) an înainte de testare.

CĂLĂTORII

Indiferent dacă plecați în interes de serviciu sau pentru vacanță, iată câteva lucruri de luat în considerare când vă pregătiți pentru călătorie.

Sfaturi utile pentru planificarea călătoriei

- Purtați întotdeauna informații de contact de urgență. Puteți găsi Cardurile de Urgență HAEi în multe limbi în Aplicația HAEi Companion sau online pe haei.org.
- Caută informații despre îngrijirea medicală în țară pe care o vizitați. Găsiți o listă a medicilor și spitalelor care știu despre AEE în aplicația HAE Companion sau haei.org.
- Păstrați medicamentele AEE într-un bagaj de mână.
- Asigurați-vă că aduceți suficiente medicamente pentru întreaga călătorie.





DESPRE HAEi

HAE International (HAEi) este o rețea globală non-profit de asociații de pacienți dedicată îmbunătățirii vieții persoanelor cu AEE.

Este formată dintr-un grup de pacienți și aparținători care contribuie la conștientizarea AEE, la îmbunătățirea timpului de diagnosticare și susțin ferm aprobarea și rambursarea medicamentelor care pot salva viețile celor care trăiesc cu AEE.

HAEi este neutră față de companii și produse și susține cu entuziasm cercetarea pentru descoperirea de medicamente destinate noii generații de terapii AEE. Succesul nostru deosebit în sprijinirea studiilor clinice a dus la o varietate de opțiuni terapeutice aprobate. Lucrăm îndeaproape cu medici experți pentru a încuraja continuu o abordare personalizată, axată pe pacient, a utilizării opțiunilor terapeutice disponibile.



RESURSELE HAEi

Oferim organizațiilor noastre membre instrumente special concepute și asistență tehnică care promovează educația despre boală și activitățile de sprijin adresate nevoilor unice ale pacienților AEE și ale familiilor acestora.

În acest document veți găsi câteva informații despre aceste resurse - mai multe informații pe site-ul haei.org.



Aplicația HAE TrackR

Dezvoltat de pacienți cu AEE din cadrul HAEi, **HAE TrackR** este un jurnal electronic ușor de utilizat, conceput pentru a înregistra atacurile dvs. de AEE, tratamentele și impactul pe care AEE îl are asupra vieții dvs. și a celor dragi.

HAE TrackR este o aplicație securizată, neutră față de produse și companii, unde toate datele colectate sunt proprietatea exclusivă a utilizatorului. Protejează strict datele și confidențialitatea dumneavoastră și este pe deplin conformă cu GDPR-ul UE.

HAE TrackR este un instrument pe care atât pacienții, cât și medicii îl pot utiliza pentru a lua decizii importante privind modul optim de gestionare a AEE. De exemplu, puteți alege să trimiteți medicului dumneavoastră un raport al atacurilor și tratamentelor.

HAE TrackR poate fi accesat de pe orice dispozitiv (smartphone, tabletă sau computer) din orice colț al lumii – vizitați haetrackr.org pentru a afla mai multe și a începe să utilizați aplicația.



Carduri de urgență

HAEi a dezvoltat carduri de urgență care conțin informații clare și concise despre AEE și tratamentul necesar în timpul unui atac. Cardurile de urgență

sunt disponibile în multe limbi, atât prin aplicația noastră HAE Companion, cât și pe site-ul HAEi.



Aplicația HAE Companion

Aplicația HAE Companion oferă o cale accesibilă de a salva și de a accesa cardurile de urgență electronice.

Aplicația este disponibilă atât în App Store-ul Apple, cât și în Google Play pentru platforma Android.

Aplicația include întreaga gamă de carduri de urgență dezvoltate de HAEi și permite utilizatorilor de smartphone-uri să le descarce pe dispozitivul lor. HAE Companion oferă, de asemenea, link-uri către informații de contact despre centrele ACARE (Centrele de Referință și Excelență pentru Angioedem), precum și spitale și medici cu cunoștințe AEE din întreaga lume. Folosind Google Maps sau Apple Maps, aplicația indică direcțiile și distanța până la cel mai apropiat loc.



Programul de Acces Global

Programul de Acces Global (GAP) HAEi este disponibil pentru a oferi acces la medicamente pentru AEE în țările unde terapiile moderne nu sunt altfel disponibile. Acesta este primul program de acest fel în domeniul AEE și, credem noi, prima dată când un astfel de program a fost inițiat de o organizație de pacienți.

HAEi este angajată să asigure accesul la medicamentele AEE pentru pacienții din întreaga lume. Suntem extrem de mândri că am stabilit HAEi GAP cu partenerii noștri actuali și vom continua să lucrăm cu alți producători cu speranța de a extinde programul în viitor.



Site web și rețele sociale

Pe site-ul nostru – haei.org – veți găsi o mulțime de informații utile legate de HAE, de exemplu, informații despre boală și tratamente, povești ale pacienților, un centru de resurse cuprinzător cu linkuri către reviste, informații despre studii clinice, știri și evenimente etc.

Site-ul nostru conține, de asemenea, informații despre aproape 100 de organizații membre din întreaga lume.

Pe rețelele sociale puteți fi la curent cu știrile legate de AEE și vă puteți alătura unui grup de Facebook privat pentru persoanele cu AEE și îngrijitorii lor pentru a crea o rețea într-un mediu sigur și închis:



Grup Facebook: facebook.com/groups/HAEinernational



Pagină Facebook: facebook.com/haeinernational



Instagram: instagram.com/hae_international



Twitter: twitter.com/HAEDAY



LinkedIn: linkedin.com/company/3363107



hae day :-) creșterea conștientizării globale

Din 2012, sărbătorim **hae day :-)** în fiecare an pe 16 mai.

hae day :-) este un eveniment important, cu organizațiile noastre membre care promovează și își folosesc creativitatea pentru a crește conștientizarea despre AEE.

hae day :-) unește comunitatea AEE, cu 16 mai ca punct central pentru activități menite să crească conștientizarea despre AEE în rândul publicului larg, al profesioniștilor din domeniul sănătății, al factorilor de decizie din sănătate și al reprezentanților industriei.

În anii trecuți, plimbările noastre au unit oameni din întreaga lume pentru a crea conștientizare pentru AEE.

În 2021, am sărbătorit cel de-al 10-lea **hae day :-)** cu o campanie extinsă de activități care a inclus nu doar mersul pe jos, ci și tot felul de activități fizice sau de recreere. Acestea au fost convertite în pași care ne-au purtat prin fiecare dintre regiunile noastre pentru a vizita toate organizațiile noastre membre.

Veți găsi mai multe informații și inspirație pe haeday.org.

Revista Global Perspectives

Publicată trimestrial, Revista Global Perspectives a HAEi oferă o prezentare cuprinzătoare a aproape tot ceea ce se întâmplă în lumea AEE, incluzând articole inspiraționale cu pacienți cu AEE, informații detaliate de la organizațiile noastre membre, studii clinice în desfășurare și cele mai recente știri din industrie.

Găsești toate edițiile revistei pe site-ul nostru haei.org.



Conferințe și ateliere HAE

Prin conferințele și atelierele HAEi, reunim persoane cu AEE, îngrijitori, profesioniști din domeniul sănătății și reprezentanți ai industriei. Aceste evenimente oferă participanților un mediu axat pe AEE, care facilitează schimbul de cunoștințe, experiențe și strategii pentru extinderea accesului la și rambursarea tratamentelor moderne pentru AEE.

Din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19, conferința din 2020 a fost desfășurată cu succes virtual, iar toate prezentările pot fi găsite pe haei.org.

De asemenea, din cauza pandemiei COVID-19, atelierele noastre regionale în persoană au fost transformate în evenimente online pe care le puteți găsi, de asemenea, pe site-ul nostru. Toate prezentările sunt înregistrate în limbile materne ale vorbitorilor și subintitrate în limbile regiunilor.

Comunitatea Tinerilor

Comunitatea tinerilor HAEi este pentru pacienții cu AEE și îngrijitorilor lor, rudelor și partenerilor de viață cu vârste între 12 și 25 de ani.

Comunitatea este pentru toți tinerii, indiferent dacă sunt nou diagnosticați cu AEE și caută mai multe informații și sprijin, încep o școală nouă și ar dori să cunoască experiențele altora sau se mută într-o nouă țară și caută noi conexiuni.

Pe site-ul pentru tineri, părinții pot găsi o colecție de cărți de activități, pagini de colorat și resurse pentru copii, elaborate de organizațiile membre HAEi din întreaga lume, pentru a ajuta la explicarea AEE într-un mod distractiv și responsabil.

Grupul Consultativ al Tinerilor HAEi este alcătuit din șase (6) membri ai comunității, toți voluntari, care supraveghează direcția și obiectivele pe termen lung ale Comunității Tinerilor HAEi, promovează activitatea comunității, desfășoară diverse proiecte și campanii pe rețelele de socializare și, nu în ultimul rând, acționează ca punct de contact între Comunitatea Tinerilor HAEi și HAEi.

Dacă vrei să afli mai multe despre comunitatea tinerilor HAEi, vizitează site-ul lor youngsters.haei.org.



A photograph of two young women with blonde and brown hair, both wearing light blue t-shirts, looking at a large world map. The woman on the left is pointing at a country in North Africa (Algeria), and the woman on the right is pointing at South Africa. The map is color-coded by region: North America (yellow), South America (yellow), Europe (yellow), Africa (red/orange), Asia (red), and Australia (yellow). The text 'HAEi YOUNGSTERS' is in a smaller font above the main title. The main title 'CONNECTED BY HAE. UNITED AS A FAMILY.' is in large, bold, white capital letters with a slight shadow effect. The background is a large world map with various countries labeled.

HAEi YOUNGSTERS

**CONNECTED BY HAE.
UNITED AS A FAMILY.**



Read more on haei.org · March 2022